DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA NELLY CIFUENTES DE GUATAPI **Identificación** CC 29869812
Edad: 80 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y53	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	Y57	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K296 OTRAS GASTRITIS

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 08:30:00 **Hora Final** 08:50:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: TRASTORNO DEGLUTIVO
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO,
VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 38 COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL.
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO NORMALES.
MUCOSA DE CUERPO SIN ALTERACIONES. ANTRO CON ERITEMA DIFUSO EN REGION PREPILORICA ADEMAS SE OBSERVAN LESIONES MUCOSAS DE ASPECTO METAPLASICO EN REGION PREPILORICA, PILORO FRANQUEABLE.
DUODENO: NORMAL HASTA SEGUNDA PORCIÓN
BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO FRASCO 2. CUERPO
***CONCLUSION:
1.GASTRITIS CORPOROANTRAL MODERADA
2. LESIONES MUCOSAS DE ASPECTO METAPLASICO EN REGION PREPILORICA
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
COLONOSCOPIA TOTAL
***INDICACIÓN: DOLOR ABDOMINAL
SE INTRODUCE COLONOSCOPIO OLYMPUS
INSPECCIÓN: NO ORIFICIOS FISTULOSOS, NO FISURAS, NO HEMORROIDES EXTERNAS, NO PLIEGUES CUTANEOS REDUNDANTES.
TACTO RECTAL: ESFINTER NORMOTONICO, NO MASAS PALPABLES, DEDO DE GUANTE SALE LIMPIO.
ANOSCOPIA: CANAL ANAL SIN ALTERACIONES, LINEA DENTADA DE CONFORMACION HABITUAL, AMPOLLA RECTAL VACIA SIN LESIONES MUCOSAS, RETROFLEXION SIN HEMORROIDES INTERNAS. COLONOSCOPIA: SE AVANZA HASTA ILEON DISTAL EL CUAL SE ENCUENTRA CON MUCOSA DE CARACTERISTICAS NORMALES, EN RETIRADA SE EXPLORAN TODAS LAS PORCIONES DEL

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

COLON ENCONTRANDO POLIPO DE APROX 9 MM DE DIAMETRO SESIL EN COLON TRANSVERSO, ADEMAS SE OBSERVA LESION DE CRECIEMINTO LATERAL LST- NG DE UNOS 2 CM DE DIAMETRO CERCANO HA ANGULO ESPLENICO DEL COLON DEMAS AREAS PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES APARENTES. PREPARACIÓN BOSTON CD: 1, CT: 2, CI: 2
5/9.
***CONCLUSIÓN:
1.POLIPO DE APROX 9 MM DE DIAMETRO SESIL EN COLON TRANSVERSO EL CUAL SE DEBE PROGRAMAR PARA RESECCION ENDOSCOPICA
2. LESION DE CRECIEMINTO LATERAL LST- NG DE UNOS 2 CM DE DIAMETRO CERCANO HA ANGULO ESPLENICO DEL COLON SE DEBE PRPGRAMAR PARA RESECCION ENDOSCOPICA

Tejidos enviados a patología : SI [X] **NO** [ ]

BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO FRASCO 2. CUERPO

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***